

Eine hoch-unterstützte autistische Person in Ihrer Pflege

Für Hausärzt:innen, Pflegeheim-Hausärzt:innen und Kliniker:innen — Versorgung einer autistischen Person in unterstützter / stationärer / hoch-unterstützter Pflege (jedes Alter).

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Für eine hoch-unterstützte autistische Person sind Pflege-Umwelten oft die **schwersten überhaupt**: sensorisch feindselig, routine-störend, voller unvorhersehbarer Berührung und Anforderung. Viele kommunizieren ohne Sprache (AAC, Verhalten oder eine vertraute andere Person) und melden Schmerz vielleicht erst, wenn schwer. Einwilligung, Kapazität und Würde hängen daran, *mit* der Aufmerksamkeit, den Routinen und den vertrauten Menschen der Person zu arbeiten — niemals von atypischer Kommunikation auf Inkapazität zu schließen.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Belastung, Selbstverletzung, „herausforderndes Verhalten“, Verweigerung	Zumeist Kommunikation über unerfüllten Bedarf — Schmerz, Angst, sensorische Überlastung, verlorene Routine
Meltdown oder Shutdown während der Pflege	Unwillkürliche Nervensystem-Reaktion auf Überlastung — <i>keine</i> Aggression oder Non-Compliance
Meldet keinen Schmerz; plötzlicher Zusammenbruch / späte Präsentation	Interozeptions -Unterschiede — innere Signale registrieren sich vielleicht erst, wenn schwer
Rückzug, wenn Objekte, Ordnung oder Personal wechseln	Routinen und Besitz sind Identitäts- und Sicherheitsanker
Keine verlässliche Sprache; verlässt sich auf AAC, Verhalten oder eine Begleitperson	Atypische Kommunikation ≠ Kapazitäts- oder Verständnismangel

Versuchen Sie dies

- **Bauen Sie Pflege um Vorhersagbarkeit:** konsistentes Personal, derselbe Ablauf, visuelle Zeitpläne, Vorwarnung jedes Wechsels.
- **Senken Sie die sensorische Last** — ruhiger Raum, gedimmtes Licht, weniger Signaltöne und starke Gerüche; bewahren Sie die eigenen Objekte, Interessen und Routinen der Person.
- **Untersuchen Sie Schmerz und körperliche Ursachen zuerst** bei jeder neuen Belastung oder Verhaltensänderung — Verstopfung, Zahnschmerz, Infektion, schlecht sitzende Hilfsmittel sind häufige, verborgene Übeltäter.
- **Nutzen Sie unterstützte Entscheidungsfindung:** erklären Sie in zugänglicher, wörtlicher Form; gewähren Sie Verarbeitungszeit; konsultieren Sie die vertraute Begleitperson und jedes Vorsorge-/Kommunikations-Profil.
- **Haben Sie einen ruhigen, schriftlichen Meltdown-/Shutdown-Plan:** reduzieren Sie Stimulation, sichern Sie Sicherheit, geben Sie Zeit und Raum — fixieren oder bestrafen Sie nicht.

Vermeiden Sie dies

- Belastung als „verhaltensbedingt“ etikettieren, bevor Schmerz und Überlastung ausgeschlossen sind.
- Fixierung oder Sedierung als erste Antwort auf Meltdown/Shutdown nutzen.
- Routinen, Objekte oder Interessen „zu ihrem Besten“ entfernen oder von atypischer Kommunikation auf Kapazitätsmangel schließen.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Behandeln Sie **neue oder eskalierende Belastung** als medizinisches Warnsignal, bis Schmerz, Infektion, Verstopfung, Zahnprobleme und sensorische/umweltbedingte Ursachen ausgeschlossen sind. Screenen Sie auf **autistisches Burnout** unter chronischer Last. Beziehen Sie **spezialisierte Autismus-/Lernschwierigkeiten-Teams** und Logopädie (AAC) ein. Dokumentieren Sie ein individualisiertes **Sensorik-, Kommunikations- und reasonable-Anpassungen-Profil** und betten Sie es in den Pflegeplan ein.

Geschlechter-Hinweis

Hoch-unterstützte Frauen sind besonders unter-erkannt und unter-versorgt; ihre Belastung wird noch häufiger fehl-gelesen. Wenden Sie dieselbe Sorgfalt beim Ausschluss von Schmerz und Überlastung an, unabhängig vom Erscheinungsbild oder der Kommunikationsmethode.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — das **Monotropismus-Dossier** und der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teile 3.5 & 4) plus der Leitfaden für die **Familie** (Teil 5, Pflegeheime & Krankenhäuser). Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug.** Passen Sie es an die einzelne Person an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, Interozeption/Schmerz); AASPIRE AHAT; Autism Society (2025, Meltdowns/Shutdowns); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.